

Nutritional Risk Screening (NRS 2002)

Vorscreening:

- Ist der Body Mass Index $< 20,5 \text{ kg/m}^2$? ☐ ja ☐ nein
- Hat der Patient in den vergangenen 3 Monaten an Gewicht verloren? ☐ ja ☐ nein
- War die Nahrungszufuhr in der vergangenen Woche vermindert? ☐ ja ☐ nein
- Ist der Patient schwer erkrankt? (z.B. Intensivtherapie) ☐ ja ☐ nein

- ▷ Wird **eine** dieser Fragen mit „Ja“ beantwortet, wird mit dem Hauptscreening fortgefahren
- ▷ Werden alle Fragen mit „Nein“ beantwortet, wird der Patient wöchentlich neu gescreent.
- ▷ Wenn für den Patienten z.B. eine große Operation geplant ist, sollte ein präventiver Ernährungsplan verfolgt werden, um das assoziierte Risiko zu vermeiden.

Hauptscreening:

Störung des Ernährungszustands	Punkte		Krankheitsschwere	Punkte
Keine	0		Keine	0
Mild	1		Mild	1
Gewichtsverlust $> 5\%$ / 3 Mo. oder Nahrungszufuhr $< 50 - 75\%$ des Bedarfes in der vergangenen Woche			z.B. Schenkelhalsfraktur, chron. Erkrankungen bes. mit Komplikationen: Leberzirrhose, chron. obstruktive Lungenerkrankung, chron. Hämodialyse, Diabetes, Krebsleiden	
Mäßig	2	+	Mäßig	2
Gewichtsverlust $> 5\%$ / 2 Mo. oder BMI $18,5 - 20,5 \text{ kg/m}^2$ und reduzierter Allgemeinzustand oder Nahrungszufuhr $20 - 60\%$ des Bedarfes in der vergangenen Woche			z.B. große Bauchchirurgie, Schlaganfall, schwere Pneumonie, hämatologische Krebserkrankung	
Schwer	3		Schwer	3
Gewichtsverlust $> 5\%$ / 1 Mo. ($> 15\%$ / 3 Mo.) oder BMI $< 18,5 \text{ kg/m}^2$ und reduzierter Allgemeinzustand oder Nahrungszufuhr $0 - 25\%$ des Bedarfes in der vergangenen Woche			z.B. Kopfverletzung, Knochenmarktransplantation, intensivpflichtige Patienten (APACHE-II > 10)	

+ 1 Punkt, wenn Alter ≥ 70

≥ 3 Punkte Ernährungsrisiko liegt vor, Erstellung eines Ernährungsplanes

< 3 Punkte wöchentlich wiederholtes Screening. Wenn für den Patienten z.B. eine große Operation geplant ist, sollte ein präventiver Ernährungsplan verfolgt werden, um das assoziierte Risiko zu vermeiden.